

PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SUS – PS 2023

Período de Vigência: 12 meses a partir da data da assinatura.

Convênio nº. 01/2021

Processo nº. 422/2022

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Razão Social da Instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena

CNES: 2087111

CNPJ: 51.779.304/0001-30

Endereço: Rua Dom Bosco, 562 - Centro

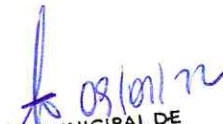
Município: Lorena

Provedor: Mário Teixeira da Silva

Diretor Clínico: Antônio Fernando Costa Filho

Diretor Técnico: Jose Reinaldo de Araújo Vilela

Enfermeiro Responsável: Elaine Cristina Virginio


SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE LORENA-SP
Rua Benedito Marcondes de
Moura Sobrinho, 38
(12) 3159-3300

II – OBJETO

- a) Prestar assistência de Urgência e Emergência conforme Resolução CFM 2077/2014 e portaria SAS/MS n.º 461 de 11/06/2014, com suporte médico especializado em ginecologia/obstetrícia, ortopedia, anestesia, cirurgia, neuro clínico, cirurgia pediátrica, gastroenterologia, oftalmologia, vascular, bucomaxilo, cardiologia e nefrologia conforme Resolução CFM 2077/2014.
- b) Prestar serviços médico-hospitalares de média e alta complexidade com suporte integral de equipe técnica, ofertar consultas, diagnose, cirurgias de urgência e eletivas, leitos clínicos, obstétricos, conforme Resolução - SS 42 de 06/05/2015, cirúrgicos, pediátricos, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adultos e neonatal, visando garantia da atenção integral à saúde dos munícipes de Lorena, Canas e Piquete na qual a CONVENIADA está inserida.
- c) Prestar serviços médico-hospitalar aos pacientes que derem entrada via serviço de urgência/emergência e necessitarem de procedimentos de hemodinâmica intervencionista na especialidade de cardiologia, especificamente os casos de pacientes infartados, que cumpram os protocolos de Infarto Zero ao qual, serão solicitados autorização a Central de Regulação do município ou inseridos no módulo CROSS para vagas de referência.

III – CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Missão da Instituição: Sociedade civil, sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica. Estabelece como missão prestar assistência à saúde da comunidade de forma igualitária, com excelência técnica,



humana e espírito inovador, incorporando ações sociais e educativas, garantindo a satisfação dos clientes e colaboradores, com princípios éticos e a qualidade de vida.

Natureza Jurídica: Entidade Beneficente Sem Fins Lucrativos

Presta atendimento Ambulatorial: Sim● Não○

Presta atendimento Hospitalar: Sim● Não○

Presta atendimento de Urgência e Emergência: Sim● Não○

IV – CARACTERIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

HOSPITALAR

Salas	Nº	Leitos
Sala de Cirurgia	5	5
Sala de Recuperação Pós-anestésica	1	6

SERVIÇO DE APOIO

Tipo de Serviço	Procedência
Ambulância	Pertencente à Frota Municipal
Central de Esterilização de Materiais	Próprio e Terceirizado
Farmácia	Próprio
Lactário	Próprio
Lavanderia	Próprio/Terceirizado
Necrotério	Próprio
Nutrição e Dietética (S.N. D)	Próprio
Serviço de Sangue e Hemoderivados	Próprio e Terceirizado
S.A.M.E ou S.P.P. (Serviço de Prontuário de Paciente)	Próprio e Terceirizado
Serviço de Manutenção	Próprio e Terceirizado
Serviço Social	Próprio

INTERNAÇÃO

Número de leitos distribuídos por especialidades, disponibilizados ao SUS:

Tipos de leito por Especialidades	Nº. de leitos SUS
Cirurgia Geral	22



Clínica Médica	37
Obstetrícia Clínica/Cirúrgica	16
Pediatria Cirúrgica/Clínica	10
TOTAL	85

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA HABILITADA:

Especialidades	Nº. Total de leitos conforme CNES
Adulto tipo II	20
Neonatal tipo II	10

*14 leitos habilitados UTI SUS Adulto

*07 leitos habilitados Neonato

V– METAS FÍSICAS

ATENDIMENTOS CONTRATADOS PELO SUS

a) ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA:

A assistência ambulatorial eletiva se desenvolverá na Santa Casa Lorena a partir do agendamento de natureza eletiva que deverá ser realizado através do sistema da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE onde, obrigatoriamente deverá contar a identificação do atendimento SUS, através do SISTEMA OFICIAL DE REGULAÇÃO DO SUS a ser definido pela Contratante.

A definição dos pacientes a serem agendados para esta assistência é de responsabilidade exclusiva da Contratante, sendo de responsabilidade da Contratada a disponibilização dos recursos materiais e assistenciais (enfermagem), bem como a definição dos dias, locais e horários em que os pacientes serão atendidos. Esta agenda deve ser disponibilizada ao contratante em um prazo mínimo de 30 dias de antecedência à data da realização dos exames.

Os pacientes que devam ter continuidade de tratamento deverão ser contra referenciados para a REDE SUS por meio de instâncias reguladoras competentes.

Tratamento	Quantidade pactuada	Municípios referenciados
Esofagogastroduodenoscopia (Endoscopia)	No limite de 100	Lorena
Colonoscopia	No limite de 50	Lorena
Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE)	No limite de 10	Lorena



b) ATENDIMENTO HOSPITALAR:

METAS FÍSICAS DE ATENDIMENTOS CONTRATADOS PELO SUS – HOSPITALAR, abaixo segue a tabela com os quantitativos físico e financeiro de atendimentos hospitalares (AIH's) a serem realizados por meio deste instrumento (financiados por MAC):

ESPECIALIDADES		AIH /Mês
Hospitalar Enfermaria	Clínica Cirúrgica	479
	Obstetrícia	
	Clínica médica	
	Pediatria	

Os procedimentos cirúrgicos eletivos do módulo 1 e módulo 2, de média complexidade deverão obedecer a seguinte programação:

PROCEDIMENTOS PRIORITÁRIOS	QUANTIDADE MÊS	Valorado Tabela SUS acima de R\$ 500,00	Valorado Tabela SUS até R\$ 500,00
Geral	30	Módulo I	Módulo II
Vascular	30		
Ginecológica	08		
Oftalmológica – Catarata	10		
Ortopedia	10		
TOTAL	88		

Neste total, incluem-se as UTI's, as quais devem realizar um quantitativo de produção, conforme tabela abaixo:

Tipo	Leitos	Diárias UTI Mensal
Adulto	14	420
Neonatal	7	210

CARACTERÍSTICAS E FLUXOS PARA OS ATENDIMENTOS HOSPITALARES CONTRATADOS PELO SUS:

1) PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ELETIVOS:



Os atendimentos hospitalares de média e alta complexidade, de natureza eletiva, serão disponibilizados aos usuários do **SUS** que tiverem essa necessidade identificada nos serviços ambulatoriais eletivos da rede municipal de saúde.

A identificação da origem da indicação da internação eletiva deverá ser efetivada por ocasião da emissão do Laudo Médico para emissão de AIH. Todos os Laudos Médicos para emissão de AIH deverão ser emitidos através do sistema da Secretaria Municipal de Saúde, onde, obrigatoriamente deverá constar a identificação do atendimento SUS onde foi gerada a indicação da internação.

As internações eletivas somente deverão ser efetivadas pela Santa Casa Lorena após prévia autorização da Secretaria Municipal de Saúde.

O quantitativo de cirurgias eletivas mensais a serem realizadas está na tabela acima e corresponde a 88 cirurgias/mês.

Estas cirurgias devem ser oferecidas nas diversas especialidades cirúrgicas necessárias, objeto de pactuação específica entre o prestador e o gestor de acordo com a necessidade detectada nos serviços ambulatoriais SUS do município.

2) ATENDIMENTO INTEGRAL HOSPITALAR:

A Santa Casa responsabilizar-se-á pela realização do atendimento integral do paciente internado, e se necessário buscará referências na rede **SUS** intermunicipal / Estadual, para assegurar ao paciente toda assistência necessária, bem como todos os medicamentos e exames e condutas prescritos pelos assistentes dos pacientes internados, ou seja, atuará de modo a lhes garantir um atendimento integral e conclusivo.

Este atendimento integral poderá acontecer no próprio hospital quando sua complexidade o permitir, e também em outros serviços SUS quando por ele forem referenciados.

VI – METAS QUALITATIVAS - INDICADORES

a) Relatórios de Gestão – Encaminhar os seguintes relatórios em até 10 (dez) dias úteis após o encerramento de cada quadrimestre do ano civil, juntamente com a documentação da prestação de contas quadrimestral que se refere os incisos XII e XIII do art. 188 da IN nº 01/2021 do TCE/SP, em especial a estabelecida na cláusula décima quinta, inciso II, letra “o”.

1. Revisão de óbito

- Relatório da Comissão de Revisão de óbitos com análise dos óbitos por faixa etária e medidas adotadas.

2. Relatório de CCIH (Controle de Infecção Hospitalar)

- Relatório da CCIH com análise das ocorrências do período e das medidas adotadas (centro cirúrgico, UTI, berçário, patológico, etc.).



3. Partograma

4. Revisão de Prontuário

- Relatório contendo itens relacionados à organização dos prontuários e a qualidade dos registros.

5. Ética Médica

- Ata de reunião específica, no período.

6. Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validados pelos gestores.

- Utilizar normativas regulamentadas no âmbito do SUS.

7. Realizar a gestão de leitos hospitalares com vistas à otimização dos leitos.

- Relatório demonstrativo da Média Permanência e Taxa de Ocupação dos leitos pactuados.

8. Disponibilizar o acesso dos prontuários à autoridade sanitária, bem como aos usuários e pais ou responsáveis de menores, de acordo com o Código de Ética Médica respeitando os preceitos da LGPD,

- Relatório de controle de disponibilização dos prontuários conforme demanda.

9. Manter os dados do CNES atualizados, em especial dos serviços, equipamentos e recursos humanos. A entidade se compromete a encaminhar quadrimestralmente ao Gestor local o relatório do período com relato resumido das alterações, inclusões e exclusões ocorridas no período.

- Relatório do CNES

10. Apresentar, no mínimo 95% das altas hospitalares, no faturamento hospitalar ao SUS na própria competência, ou seja, no início do mês subsequente.

- Relatório do SIHD

11. Taxa de Mortalidade Hospitalar

- Relatório do SIHD

12. Densidade de Incidência de Infecção por cateter venoso central (CVC)

- Relatório do SIHD

b) Participar nas Políticas prioritárias do SUS

1) Humaniza SUS



a) Implantar sistema de avaliação de satisfação do usuário internado e ambulatorial conforme preconizado no Programa Nacional de Humanização em consenso com o Gestor Municipal.

Indicador: relatório com o resultado da pesquisa (Ouvidoria)

b) Implantar visita aberta, de forma a garantir a ampliação do acesso dos visitantes ao Serviço de Urgência e Emergência e às unidades de internação se autorizado pela área técnica.

Indicador: relatório com demonstrativo das visitas aos pacientes.

c) Garantir aos usuários internados, especialmente os idosos, gestantes, crianças e adolescentes o direito a acompanhante 24 (vinte e quatro horas) por dia, de acordo com a estrutura disponível.

Indicador: relatório com demonstrativo dos acompanhantes.

d) Implementar acolhimento e protocolo de classificação de risco e vulnerabilidades específicas.

Indicador: Relatório demonstrativo da classificação de risco.

e) Garantir o direito de crianças e adolescentes de brincar, oferecendo brinquedoteca.

Indicador: relatório com demonstrativo da utilização de brinquedoteca (ou fotos, preserva a identidade da criança).

f) Assegurar a alta hospitalar responsável, conforme estabelecido na PNHOSP (Portaria 3.410 de 30/12/2013).

Indicador: Fornecimento de orientações dos pacientes e familiares quanto à continuidade do tratamento. Relatório de contrato com a RAS, em particular a Atenção Básica, referente aos pacientes contra referenciados. Implantação de mecanismo de desospitalização.

g) Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente e Plano de Segurança do Paciente.

Indicador: Regimento do Núcleo de Segurança do Paciente. Atas de reunião. Implantação dos protocolos de Identificação do Paciente, Higienização das mãos, Cirurgia Segura, Prevenção de Quedas, Prevenção de Úlceras. Relatórios registro de notificações de incidentes.

h) Disponibilizar informações sobre as intervenções, solicitando ao usuário consentimento livre e esclarecido para a realização do procedimentos terapêuticos, de acordo com as legislações específicas.

Indicador: Autorização nos prontuários.

2) Atenção à saúde materno-infantil (Rede Cegonha)

a) Desenvolver políticas de incentivo ao aleitamento materno.



Indicador: Apresentar relatório com número de partos e parturientes orientadas.

b) Efetuar avaliação de anoxia neonatal (apgar).

Indicador: Apresentar prontuários com fichas de registro de apgar.

c) Efetuar controle da taxa de parto cirúrgico.

Indicador: Apresentar relatório com número total de partos, partos normais e partos cirúrgicos, no mesmo período.

d) Participar efetivamente do Comitê de Mortalidade Materna e Neonatal da Vigilância Epidemiológica Municipal.

Indicadores: Apresentar Atas das reuniões.

e) Efetuar vacinação BCG

Indicadores: Apresentar relatório com número total de nascimentos e Rn's vacinados no mesmo período.

f) Efetuar vacinação Hepatite B

Indicadores: Apresentar relatório com número total de nascimentos e RN's vacinados no mesmo período.

g) Efetuar teste do Pézinho.

Indicadores: Apresentar relatório com número total de nascimentos e RN's com teste do pezinho realizado.

h) Efetuar teste da orelhinha (ouvido)

Indicadores: Apresentar relatório com número total de nascimentos e RN's com teste da orelhinha realizados.

i) Efetuar teste do olhinho

Indicadores: Apresentar relatório com número total de nascimentos e RN's com teste do olhinho realizados.

j) Efetuar teste do coraçãozinho

Indicadores: Apresentar relatório com número total de nascimentos e RN's com teste do coraçãozinho realizados.

k) Proporção de recém-nascidos com baixo peso ao nascer - faixas < 750g, 750 a 1499g e 1500 a 2499g.



Indicadores: Nº de recém-nascidos com peso ao nascer nas faixas de < 750g, 750 a 1499g e 1500 a 2499g em um determinado período e local de residência/Nº total de recém-nascidos no mesmo período e local x 100.

l) Proporção de recém-nascidos prematuros

Indicadores: Nº de recém-nascidos com idade gestacional ao nascer < 37 semanas em um dado período e local de residência/Nº total de recém-nascidos no mesmo período e local x 100.

m) Proporção de recém-nascidos filhos de mães adolescentes

Indicadores: Nº de recém-nascidos filhos de mães com idade < 16 anos em um dado período e local de residência/Nº total de recém-nascidos no mesmo período e local x 100.

n) Cesárea em primíparas

Indicadores: Apresentar relatório com número total de cesárias x cesárias em primíparas.

3) HIV/DST/AIDS

a) Realizar teste rápido para HIV em parturientes que não apresentem teste HIV no pré-natal.

Indicadores: Apresentar relatório com número total de partos e número de testes realizados.

b) Realizar exames de VDRL e TPHA confirmatório, conforme Portaria 2.104/GM.2002

Indicadores: Realizar notificação compulsória de sífilis congênita, de gestantes HIV + e de crianças expostas.

c) Disponibilizar administração do AZT xarope, na maternidade, para os RN filhos de mães soropositivas para HIV, diagnosticadas no pré-natal ou na hora do parto, garantindo-se que a primeira dose seja administrada, ainda na sala de parto.

Indicadores: Apresentar registro específico em prontuário.

VII – GESTÃO HOSPITALAR

Apresentar os aspectos centrais da gestão e dos mecanismos de gerenciamento e acompanhamento das metas físicas e de qualidade acordadas entre instituição e gestor e que deverá conter:

- Equipe de monitoramento e acompanhamento do Convênio/Plano Operativo, cuja indicação será formalizada por meio de ofício.
- Encaminhar todas as informações ou relatórios solicitados e pactuados neste plano operativo, nos prazos fixados. Deverá ainda participar das reuniões de avaliação na SMS.
- Apresentação anual das licenças/alvarás da Vigilância Sanitária ou o protocolo de renovação.



- d) Elaboração de planejamento hospitalar em conjunto com a equipe multiprofissional visando às metas setoriais específicas para cada área de atuação. Promovendo ou permitindo a participação de técnicos ou dirigentes em cursos de capacitações, treinamentos que possam contribuir com a melhoria do funcionamento da instituição. Apresentar relatório trimestral com o nome, curso e data que seus funcionários ou prepostos participaram.
- e) Aplicação de ferramentas gerenciais que induzam a horizontalização da gestão, a qualificação gerencial e ao enfrentamento das questões corporativas, incluindo rotinas técnicas e operacionais, sistema de avaliação de custos, sistema de informação e avaliação de satisfação do usuário.
- f) Gestão administrativa – financeira que agregue transparência ao processo gerencial da instituição, inclusive com a abertura de planilhas financeiras e de custos para acompanhamento das partes, garantindo equilíbrio econômico do convenio/contrato firmado e regularidade de pagamento integral e a termo da contraprestação.
- g) Ações que garantam, ao longo do ano, continuidade da oferta de serviços de atenção à saúde, independente do desenvolvimento das atividades de ensino.
- h) Garantia da aplicação integral na Unidade hospitalar dos recursos financeiros de custeio e de investimento provenientes do SUS.

IX – VALORES

Os critérios e a respectiva pontuação para esta avaliação encontram-se no anexo deste plano operativo e serão utilizadas como base para os repasses financeiros do período subsequente ao da avaliação.

Na tabela abaixo se encontram as faixas de pontuação e o percentual da parcela variável do recurso financeiro deste plano operativo a ser percebida conforme pontuação atingida nas avaliações.

Faixas de pontuação	Percentual do valor
2.700 a 3.000	100%
2.400 a 2.600	85%
2.000 a 2.300	75%
< 1.700	50%

VIII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO



A avaliação de desempenho da Instituição será realizada **QUADRIMESTRALMENTE**, conforme cronograma anexo, ocasião em que será verificado o cumprimento das metas físicas e qualitativas, bem como a inserção da Unidade no sistema de Regulação e de controle. O não cumprimento de metas deverá ser informado ao serviço contratado juntamente com as medidas propostas de correção e suspensão de recursos financeiros próprios do Contratante e dos incentivos provenientes do tesouro Federal e Estadual.

Período de competência	Mês de Avaliação
Janeiro/fevereiro/março/abril	Maio
Maio/junho/julho/agosto	Setembro
Setembro/outubro/novembro/dezembro	Janeiro

PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE DESEMPENHO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Indicadores	Ref.	Monitoramento							
		Parâmetro	Ponto	Parâmetro	Ponto	Parâmetro	Ponto	Parâmetro	Ponto
Total AIH/mês	479	Abaixo de 79	200	80 a 199	400	200 a 399	600	400+	800
Cirurgia Eletiva AIH/mês	88	Abaixo de 38	100	39 a 59	200	60 a 79	300	80+	400
Taxa de ocupação	Mínimo 60%	Abaixo de 30%	0	30 a 49	50	50 a 59	100	Mínimo de 60 %	200
Média de permanência	Máximo 5 dias	Acima de 5 dias	0	-	-	-	-	Abaixo de 5 dias	200
Taxa de Mortalidade	Máximo 5%	Acima de 5%	0	-	-	-	-	Abaixo de 5%	200
Total									1.800

PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE DESEMPENHO DA ASSISTÊNCIA GERAL

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS
Comissão de revisão de óbitos	Atas/Relatório	100
Comissão de revisão de prontuários	Atas/Relatório	50
CCIH	Atas/Relatório	250
Comissão de Ética Médica	Atas/Relatório	150
Sistema de Avaliação satisfação do usuário	Relatório	150
Atualização do CNES	Relatório	100
Altas apresentada na própria competência	Relatório SIHD (Máximo 95%)	100
Índice de Infecção Hospitalar	Relatório (Máximo 5%)	150
Índice de Infecção Cateter Venoso Central	Relatório (Máximo 4%)	150
TOTAL		1200



Observações:

- A) Os indicadores que não tiverem monitoramento mensal serão automaticamente pontuados, a cada mês, em conformidade com pontuação atingida na sua última avaliação.
- B) Metas Quantitativas de atendimentos:

Percentual de Pontos (%)	Meta Quantitativa de Pontos (%)
< 70	Não pontua
71 a 80	80
81 a 90	90
91 a 100	100

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

I - Serviços Médicos de Atendimento

Atendimento em consultas médicas clínica, pediátrica, de urgência e emergência, com suporte médico especializado em ginecologia/obstetrícia, ortopedia, anestesia, cirurgia por profissional médico 24 horas por dia e 7 dias por semana, nos termos da Resolução do CFM n.º 2077/14.

Profissionais Médicos	
Especialidade	N.º Profissionais
Clínico Geral	02
Pediatra	02
Emergencista	01
Suporte Médico Especializado	
Ortopedista	01
Ginecologista/Obstetra	02
Cirurgião	02
Anestesista	01
Suporte Médico Retaguarda	
Neuro clínica	01
Cirurgia Pediátrica	01
Gastroenterologia	01
Oftalmologia	01
Vascular	01
Bucomaxilo	01
Cardiologista	01
Nefrologista	01



II - Serviços de Enfermagem

A equipe de Enfermagem será composta conforme quadro de colaboradores:

Quadro de Colaboradores	
Profissional	N.º Profissionais
Supervisão de Enfermagem	02
Enfermeiras	24
Técnicos de Enfermagem	65
Fisioterapeutas	04

Deverá garantir a classificação de risco dentro das adequações previstas na Política Nacional de Humanização e Acolhimento com mapeamento e classificação de risco nas 24 horas (Protocolo de Manchester) e a assistência de enfermagem.

Equipe de Classificação de Risco

Atendimento de Enfermagem conforme protocolo de Manchester (Classificação de risco). O serviço deve atender a toda a demanda de usuários com entrada no Serviço de Urgência e Emergência, mantendo profissional enfermeiro em número suficiente para a cobertura integral, exclusivo para esse atendimento, em local apropriado, garantindo o sigilo do atendimento e o fluxo da Unidade.

Classificação de Risco
Profissional
Enfermeiro

III - Equipe de Apoio

Serviço de profissionais técnicos e qualificados para prestação de serviço no apoio da execução do objeto do plano operativo, garantindo o fluxo de atendimento, segurança, higienização e suporte ao atendimento do usuário, conforme a seguinte programação:

Quadro de Funcionários	
Profissional	N.º Profissionais
Coordenador Médico	01
Recepcionistas	10
Porteiros/Maqueiros	07
Auxiliar Serviços Gerais	10



Assistente Social	02
Auxiliar de Farmácia	04
Estagiários	03

Quadro de Apoio	
Profissional	N.º Profissionais
Técnicos de Radiografia	07
Técnicos de Gesso	07
Auxiliar Administrativo	02
Assistente Contábil	01
Assistente de Relacionamento	01

IV – EXAMES E PROCEDIMENTOS

A CONVENIADA assumirá a realização integral dos seguintes exames e procedimentos:

- a) Exame de Radiografia
Demanda Espontânea: Sim ● Não ○
Demanda Referenciada: Sim ○ Não ●
- b) Exames de Eletrocardiografia
Demanda Espontânea: Sim ● Não ○
Demanda Referenciada: Sim ○ Não ●
- c) Exames de Análises Clínicas Laboratoriais
Demanda Espontânea: Sim ● Não ○
Demanda Referenciada: Sim ○ Não ●
- d) Exames de Ultrassonografia
Demanda Espontânea: Sim ● Não ○
Demanda Referenciada: Sim ○ Não ●
- e) Exames de Tomografia
Demanda Espontânea: Sim ● Não ○
Demanda Referenciada: Sim ○ Não ●
- f) Procedimentos Ortopédicos (Sala de Gesso)
Demanda Espontânea: Sim ● Não ○
Demanda Referenciada: Sim ○ Não ●

V – METAS FÍSICAS

Estabelecem-se as seguintes metas conforme média mensal:

a) **URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

- Atendimento médico (Clínica adulta e pediátrica)



Descrição dos Procedimentos
Número de atendimentos de adultos
Número de atendimentos de crianças

▪ **Atendimento médico**

Descrição dos Procedimentos
Clínicos
Pediátricos
Suporte médico especializado (cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesia)

▪ **Exames**

Descrição dos Exames
Exames de Radiografias
Exames de Ultrassonografias
Exames de Tomografias
Exames de Análises Laboratoriais
Exames de Eletrocardiografia

VI – METAS QUALITATIVAS

- a) Manter em funcionamento e apresentar relatórios e Ata das reuniões das seguintes Comissões:
1. Revisão de Prontuário – **Quadrimestralmente**
 - Apresentar relatório, contendo itens relacionados à organização dos prontuários e à qualidade dos registros (preenchimento, legibilidade, assinatura, carimbo).
 2. CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) – **Quadrimestralmente**
 - Apresentar Ata da CCIH com a análise das ocorrências do período e das medidas adotadas.
 3. Ética Médica – **Quadrimestralmente**
 - Apresentar Ata de reunião específica, no período.
- b) Manter os dados do CNES atualizados, em especial dos serviços/equipamentos/recursos humanos. A entidade compromete-se a encaminhar mensalmente à Secretaria de Saúde o relatório do período com relato resumido das alterações/inclusões/exclusões ocorridas no período.
- **Indicador:** Relatório CNES.
- c) Apresentar programação anual de capacitação, cursos e treinamentos dos profissionais vinculados à prestação de serviço do objeto do plano operativo, também garantindo capacitação ao instrumento regulador CROSS ou outro que venha a ser instituído pelo SUS.
- **Indicador:** Relatório de capacitação continuada.



- d) Apresentar relatório bimestral de pesquisa interna de satisfação de usuários, conforme preconizado no Programa Nacional de Humanização e consensuado pelo Gestor municipal.
 - **Indicador:** Relatório de Satisfação Interna.
- e) Apresentar relatório mensal dos atendimentos conforme protocolo da política nacional de humanização com mapeamento e classificação de risco.
 - **Indicador:** Relatório de Classificação de Risco.

VII – GESTÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

- a) A CONVENIADA compromete-se a indicar um membro para compor a Comissão de Acompanhamento de Convênio, cuja composição será designada por intermédio de Portaria após 15 dias da assinatura do Convênio.
- b) A CONVENIADA compromete-se a apresentar anualmente as licenças/alvarás da Vigilância Sanitária ou o protocolo de renovação

VIII – CONDIÇÕES GERAIS DO OBJETO DE SERVIÇO

- a) Aos usuários que necessitem de atendimento médico hospitalar, internação ou procedimento de referência hospitalar, a CONVENIADA deverá encaminhar para o Serviço Hospitalar contratado pela CONVENIENTE, devidamente autorizado pelo órgão regulador municipal;
- b) A CONVENIADA responsabilizar-se-á pela realização do atendimento integral do paciente em estado de urgência e emergência e se necessário buscará referências na rede SUS para assegurar toda assistência à conduta prescrita pelo médico assistente;
- c) A CONVENIENTE manterá serviço de transporte com equipe técnica para os casos de transferências referenciadas e reguladas pelo sistema CROSS;
- d) A CONVENIADA será responsável pelo atendimento informatizado da Unidade, com equipamentos e manutenção própria;
- e) A CONVENIADA assumirá integralmente todas as despesas diárias de almoxarifado, material de consumo;
- f) A CONVENIADA será responsável todas as despesas diárias de almoxarifado, material de consumo.

IX – VALORES

Os critérios e a respectiva pontuação para esta avaliação encontram-se no anexo deste plano operativo e serão utilizadas como base para os repasses financeiros do período subsequente ao da avaliação.

Na tabela abaixo se encontram as faixas de pontuação e o percentual da parcela variável do recurso financeiro deste plano operativo a ser percebida conforme pontuação atingida nas avaliações.



Faixas de pontuação	Percentual do valor variável	Valor Repasse
2130 a 2.400	95 a 105%	Total Mensal: R\$ 2.000.000,00
2129 a 1860	85 a 94%	Total Mensal R\$ 1.900.000,00 Total Variável 5,0%
1859 a 1590	75 a 84%	Total Mensal R\$ 1.870.000,00 Total Variável 6,5%
< 1320	< 70%	Total Mensal R\$ 1.850.000,00 Total variável 7,5%

X- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A avaliação de desempenho do Serviço de Urgência e Emergência será realizada quadrimestralmente, conforme cronograma abaixo, ocasião em que será verificado o cumprimento das metas quantitativas e qualitativas, bem como a inserção da unidade no sistema de regulação e de controle. O não cumprimento de metas deverá ser informado ao serviço contratado juntamente com medidas propostas de correção.

Observações:

- a) Os indicadores que não tiverem monitoramento mensal serão automaticamente pontuados, a cada mês, em conformidade com pontuação atingida na sua última avaliação.

Período de competência	Mês de Avaliação
Janeiro/fevereiro/março/abril	Maio
Maio/unho/julho/agosto	Setembro
Setembro/outubro/novembro/dezembro	Janeiro

ANEXO I - PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE DESEMPENHO

QUADRO ANEXO DO INDICADOR		
Indicadores a serem monitorados	Parâmetro Quadrimestral	Pontos
Atendimentos médicos por demanda espontânea	24.680	400
Atendimento em serviço médico de retaguarda	Atendimento a todas as chamadas em até 60 minutos	400
Exames laboratoriais e de imagem	32.800	400
Total		1200





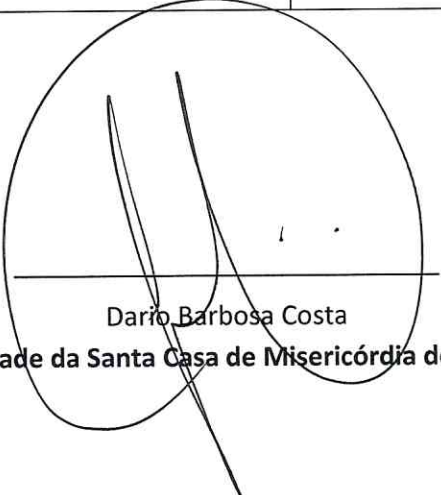
SANTA CASA
LORENA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LORENA
CNPJ 51.779.304/0001 - 30
R. Dom Bosco, 562 – Centro – Lorena/SP – CEP 12.600-100.
Telefone (12) 3159-3344
www.santacasalorena.org.br

ANEXO II – PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE DESEMPENHO

QUADRO ANEXO DO INDICADOR		
Indicadores a serem monitorados	Parâmetro Quadrimestral	Pontos
Comissão de Revisão de Prontuário	Relatório	200
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Ata	200
Comissão de Ética Médica	Ata	200
Atualização do CNES	Relatório	150
Programação de Capacitação	Relatório	150
Pesquisa Interna de Satisfação de Usuários	Relatório	150
Mapeamento e Classificação de Risco	Relatório	150
Total		1.200

Lorena, 12 de janeiro de 2023.


Dário Barbosa Costa
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena

